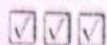


多発血管炎性肉芽腫症

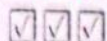
66 ~ 73

66★★★



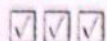
上気道、下気道、腎病変がみられることが多い。

67★★★



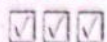
血中の PR3-ANCA が診断に有用である。

68★★★



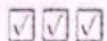
胸部画像では空洞影がみられることはない。

69★★★



標準的な寛解導入療法は rituximab を用いる。

70★★★



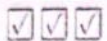
壊死性肉芽腫性血管炎を特徴とした全身性炎症性疾患である。

71★★★



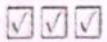
20~30 歳代に多い。

72★★★



上気道症状では難聴や耳閉感が多い。

73★★★



病理組織所見では palisading granuloma がみられる。

好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

74 ~ 80

74★★★★



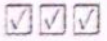
末梢血の好酸球数は増加しない。

75★★★★



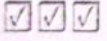
難治性喘息として加療されている患者の治療経過中に発熱や好酸球増多が出現したときに、鑑別疾患として考慮する。

76★★★★



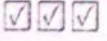
血中の MPO-ANCA が陽性となることが多い。

77★★★★



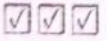
ほとんどの症例で腎症も合併する。

78★★★★



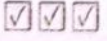
胸部 CT では線維化を伴う間質性肺炎を呈する。

79★★★★



病理組織学的には、著明な好酸球浸潤を伴う細小血管の肉芽腫やフィブリノイド壊死性血管炎を呈する。

80★★★★



抗 IL-5 抗体製剤が治療選択肢になる。

